

ESCALA DE MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS ANORMALES (AIMS)

Abnormal Involuntary Movement Scale — Detección de Discinesia Tardía

Guy / NIMH (1976) • Protocolo de cribado y monitorización de discinesia

Nombre / Código: _____ Fecha: _____

Edad: _____ años Sexo: ☐ F ☐ M ☐ Otro Evaluador: _____

INSTRUCCIONES:

Aplique el protocolo de examen de 12 maniobras de provocación. Puntúe la gravedad máxima observada en reposo o activación (-1 pto si sólo aparece con activación). Marque de 0 a 4:

0 = No | 1 = Mínimo/dudoso | 2 = Leve | 3 = Moderado | 4 = Grave | NA = No valorable

Nº	Área anatómica / Dimensión clínica	0 No	1 Min	2 Leve	3 Mod	4 Gra	NA
I. Movimientos faciales y orales							
1	Músculos de expresión facial (frente, cejas, parpadeo, muecas faciales superior)						
2	Labios y área perioral (fruncir, chasquidos, hacer pucheros, succión)						
3	Mandíbula (apretamiento, masticación, lateralización, apertura excesiva)						
4	Lengua (aumento de movimientos dentro y fuera de la boca)						
II. Movimientos de las extremidades							
5	Superiores (coreicos, atetoides, rápidos o serpentinos; excluye temblor)						
6	Inferiores (balanceo lateral de rodilla, golpeteo, inversión/eversión del pie)						
III. Movimientos del tronco							
7	Cuello, hombros y caderas (balanceo del tronco, torsión, retroversión pélvica)						
IV. Juicio global de discinesia							
8	Gravedad total objetiva de los movimientos anormales						
9	Incapacidad funcional debida a los movimientos anormales						
10	Conciencia subjetiva del paciente (0=No, 1=Sin distrés, 2=Leve, 3=Mod, 4=Grave)						
V. Estado dental / Odontológico							
11	¿Presenta el paciente problemas actuales con dientes o prótesis dentales?	Sí: ☐			NO: ☐		
12	¿Lleva o usa habitualmente dentadura postiza / prótesis dental?	Sí: ☐			NO: ☐		

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE DISCINESIA TARDÍA (Schooler & Kane, 1982)**Criterio Operativo de Discinesia Tardía:**

- Presencia de movimientos de grado **moderado** (≥ 3) en al menos **un área anatómica** (ítems 1 a 7).
- O presencia de grado **leve** (≥ 2) en al menos **dos áreas anatómicas**.
- Exige un mínimo de 3 meses de exposición neuroléptica previa.

Monitorización Clínica:

- Se recomienda aplicar AIMS cada 3-6 meses en pacientes tratados con antipsicóticos.
- Puntuación de ítems 1 a 7 = Índice de severidad discinéctica (rango 0 a 28 puntos).